GHIDUL 2 / 5

Manual de Contenție Ortodontică

Cauzele recidivei, alegerea aparatului de contenție adecvat, calendarul de control, gestionarea dezlipirilor și a recidivei. Include textul informativ pentru pacient.

Manualul Ortodontului

Cuprins

1 · De ce apare recidiva?

2 · Retainer lingual fix: 3-3 și 2-2

3 · Retainer lingual fix: fir, colaj și eșecuri

4 · Contenție mobilă: Hawley și Essix (gutieră de contenție transparentă)

5 · Alegerea contenției în funcție de tipul cazului

6 · Protocol de purtare și calendar de control

7 · Gestionarea fracturilor și a dezlipirilor

8 · Recidiva: recunoaștere și intervenție

9 · Checklist pentru predarea aparatului

10 · Informare pacient (text de înmânat)

Pasul următor

MODULUL 01

De ce Apare Recidiva?

După acest capitol, vei putea estima riscul de recidivă în orice caz, înainte de îndepărtarea bracketurilor.

> *Dinții, la finalul tratamentului, încă nu sunt „stabili". Parodonțiul, țesuturile moi și creșterea continuă să îi tragă spre poziția lor inițială. Contenția este răspunsul la aceste forțe.*

SURSA RECIDIVEI	CE SE ÎNTÂMPLĂ?	SFAT CLINIC
Fibrele gingivale și supraalveolare	În rotațiile corectate, fibrele rămân tensionate și readuc dintele la poziția inițială.	Dinții cu rotații severe la început sunt grupul cu cel mai mare risc.
Remodelarea parodontală	Până când osul și ligamentul parodontal (PDL) nu se adaptează la noua poziție, dintele este mobil.	Perioada imediat următoare îndepărtării aparatului este cea mai critică.
Echilibrul țesuturilor moi	Forțele buzei, obrajilor și limbii împing dintele înapoi în zona de echilibru.	Dacă ai protruzionat semnificativ incisivii inferiori, riscul este mare.
Modificarea formei arcadei	În special distanța intercanină inferioară tinde să revină la valoarea de dinaintea tratamentului.	Dacă este posibil, menține distanța intercanină inferioară.
Creșterea reziduală	Creșterea mandibulară tardivă poate accentua tendința de Clasa III și înghesuirile inferioare.	La pacienții în creștere cu Clasa III, planifică o contenție pe termen lung.
Obiceiuri vicioase	Dacă interpoziția linguală, suptul degetului sau mușcarea buzei persistă, ocluzia deschisă și protruzia vor reveni.	Nu îndepărta aparatul până când obiceiul nu a fost eliminat.
Finalizare incompletă	Dacă ocluzia nu este stabilă, torque-ul și paralelismul radicular sunt incorecte, dinții se vor deplasa.	Efectuează verificările de finalizare din Modulul 08 înainte de îndepărtare.

Situații inițiale cu risc ridicat

Sagital și vertical

- Ocluzie adâncă (în special Clasa II/2)
- Ocluzie deschisă frontală și interpoziție linguală
- Clasa III în creștere
- Discrepanță scheletală corectată prin camuflaj ortodontic

La nivel dentar

- Rotații severe
- Diastemă mediană, fren gros
- Înghesuire inițială severă
- Dinți erupți ectopic, ulterior aliniați

Greșeală frecventă

Să consideri contenția „ultima vizită” a tratamentului. Planul de contenție trebuie stabilit împreună cu planul de tratament, încă de la prima vizită, și explicat pacientului de la început.

Regulă practică

La consimțământul pentru tratament, folosește această frază: „Dinții tăi vor avea tendința să se deplaseze toată viața. Contenția este modul prin care controlăm această mișcare.”

MODULUL 02

Retainer Lingual Fix: 3-3 și 2-2

Decide la ce dinți îl fixezi în funcție de riscul cazului și de igiena orală.

> *Retainerul lingual fix nu depinde de complianța pacientului. De aceea, este ales cel mai des în regiunea frontală, în special la mandibulă. Prețul plătit este igiena orală și controlul periodic.*

3-3 (DE LA CANIN LA CANIN, INCLUZÂND CANINII)

- Toți cei șase dinți frontali sunt fixați.
- Alegerea clasică la mandibulă: menține caninii și incisivii împreună.
- Mai sigur în caz de rotație a caninului, înghesuire canină sau cazuri cu extracții.
- Dacă caninul inferior atinge caninii superiori, verificarea interferențelor ocluzale este obligatorie.

2-2 (DOAR INCISIVII)

- Cei patru incisivi fixați, caninii liberi.
- Alegere frecventă la maxilar: influențează mai puțin ghidajul canin și ocluzia.
- Poate fi suficient în închiderea diastemelor și pentru rotațiile incisivilor.
- Deoarece caninii rămân liberi, poate apărea recidivă în regiunea canină.

Alte opțiuni

TIP	CÂND?	ATENȚIE
Retainer fix pe toți dinții, lung	Închidere de spații extinsă până în regiunea premolară sau pierderea atașamentului parodontal.	Igiena orală este mai dificilă; planifică cu avizul medicului specialist.
Combinație fix + mobil	Cazuri cu risc crescut: retainer lingual fix + Essix sau Hawley pe timp de noapte.	Aparatul mobil să nu exercite presiune pe firul fix.

A existat rotație canină sau înghesuire în regiunea canină la mandibulă?

↓

Da → Retainer lingual fix 3-3. Verifică contactele ocluzale ale caninilor și interferențele.

Nu → În funcție de igiena orală și preferința pacientului, 3-3 sau 2-2. La maxilar, de regulă 2-2.

Eroare frecventă

Aplicarea de compozit la maxilar în punctul unde mușcă incisivii mandibulari. Când pacientul ocluzează, compozitul intră în contact și firul se dezlipește. Înainte de colare, marchează punctele de contact cu hârtie de articulație.

MODULUL 3

Retainer Lingual Fix: Fir, Colare și Eșecuri

Fir pasiv și câmp de lucru uscat: cele două condiții pentru succes.

Alegerea firului

FIR	AVANTAJ	DEZAVANTAJ
Multifilament, împletit (rotund)	Flexibil, permite mișcarea fiziologică a dinților; aderă bine la compozit.	Se poate desface sau rupe în timp; dacă se deformează, poate deveni activ.
Împletit pătrat / tip bandă	Se adaptează bine la suprafața dintelui, rezistă la rotație în compozit.	Mai rigid; adaptarea trebuie să fie precisă.
Oțel neted, monofilament	Rezistent la fractură, ușor de curățat.	Rigid; de obicei se lipește doar pe dinții terminali, dinții intermediari pot rămâne liberi.
Fir adaptat în laborator sau digital	Adaptarea pasivă este mai predictibilă.	Etapă de lucru și cost suplimentar; modelul sau scanarea trebuie să fie precise.

Colarea pas cu pas

1. **Curățare** — Curăță suprafețele linguale cu pastă de lustruit; îndepărtează tartrul în prealabil.
2. **Izolare** — Depărtător de buze și limbă, aspirator de salivă, rulouri de bumbac. În regiunea lingual mandibulară, contaminarea este cauza numărul unu a eșecului.
3. **Adaptarea firului** — Probează firul la locul lui înainte de colare. Nu trebuie să exercite presiune pe dinte și nu trebuie să atingă gingia.
4. **Gravaj și bonding** — Urmează instrucțiunile producătorului; nu contamina din nou suprafața gravată.
5. **Fixarea firului** — Menține firul în poziție pasivă cu ață dentară, port-fir sau șablon de poziționare.

6. **Compozit** — Compozit cu margini netede care înconjoară complet firul pe fiecare dinte. Zonele aproximale trebuie să rămână deschise pentru igienizare.

7. **Polimerizare și finisare** — Îndepărtează excesul, trece ața dentară prin zonele aproximale, verifică ocluzia.

Tipuri de eșecuri

TIP	CAUZĂ POSIBILĂ	PREVENȚIE
Dezlipire compozit–dinte	Contaminare, gravaj insuficient.	Izolare mai bună, câmp de lucru uscat.
Dezlipire fir–compozit	Cantitate mică de compozit, firul a rămas la suprafață.	Cantitate de compozit care să înconjoare complet firul.
Fractura firului	Oboseală, alimente dure, contact ocluzal.	Control ocluzal, educarea pacientului.
Mișcare dentară nedorită	Fir activ (deformat sau tensionat); exercită torque sau rotație pe dinte.	Fir pasiv, înlocuirea firului deformat, controale regulate.

> **Nu trebuie ignorat**
>
> Chiar și un fir lingual care pare intact poate deplasa dinții. La controale, nu verifica doar dacă „s-a dezlipit ceva", ci și dacă „dinții își mențin poziția". Dacă observi torque neașteptat pe incisivi, discrepanțe la nivelul caninilor sau recesiuni gingivale, consideră firul ca fiind activ.

MODULUL 4

Contenție Mobilă: Hawley și Essix

Două clasice, bazate pe cooperarea pacientului. Știi când este mai bun fiecare.

HAWLEY

- Placă acrilică palatinală/lingual, arc vestibular, croșete pe molari. Mai slab din punct de vedere estetic și fonetic.
- Permite erupția pasivă (settling) a dinților posteriori (nu acoperă suprafețele ocluzale).
- Reglabil pentru corecții mici; se poate adăuga plan de mușcătură frontal.
- Dacă arcul vestibular trece distal de canin, poate deschide spațiu; fii atent.

ESSIX (APARAT DE CONTENȚIE TRANSPARENT)

- Gutieră transparentă termoformată care acoperă toți dinții.
- Estetică, rapid și ieftin de realizat; se uzează rapid în caz de bruxism.
- Menține bine rotațiile frontale și alinierea.
- Acoperă suprafețele ocluzale: limitează erupția verticală.
- Se uzează, se fisurează, se colorează; necesită înlocuire periodică.
- **Greșeală frecventă:** lăsarea marginilor tăioase. Rotunjește marginile, nu irita papilele.

SITUAȚIE	CEA MAI POTRIVITĂ	DE CE
Ocluzie deschisă corectată	**Hawley** (poate fi luată în calcul și cu grilaj lingual)	Acoperirea ocluzală poate influența extruzia posterioară și erupția; controlul obiceiurilor este necesar.
Ocluzie adâncă corectată	**Hawley + plan de mușcătură frontal**	Contactul incisivilor inferiori cu planul limitează recidiva ocluziei adânci.
Rotații pronunțate, adult cu cerințe estetice ridicate	**Essix** (poate fi combinat cu retainer lingual fix)	Acoperirea totală menține bine rotația.
Expansiune transversală efectuată	**Hawley cu acoperire palatinală** sau gutieră dură	Placa acrilică rezistă la recidiva transversală.

Regulă practică

Înmanează aparatul mobil în ziua îndepărtării bracketurilor sau imediat după. Fiecare zi care trece este o fereastră pentru recidivă. Înainte de îndepărtare, ia amprenta/scanează, iar aparatul trebuie să fie gata.

MODULUL 5

Alegerea Contenției în Funcție de Tipul de Caz

Analizând problema inițială, decide în două minute asupra aparatului și duratei.

PROBLEMĂ INIȚIALĂ	MAXILAR	MANDIBULĂ	NOTĂ
Înghesuire frontală inferioară	Essix sau Hawley	Retainer lingual fix 3-3	Dacă lățimea intercanină inferioară a fost păstrată, este mai stabil.
Diastemă mediană	Retainer lingual fix 2-2 sau 1-1 + mobil nocturn	După caz	În caz de fren gros, cere aviz chirurgical.
Rotație pronunțată	Retainer lingual fix + Essix	Retainer lingual fix	Pentru chirurgia fibrelor supraalveolare, poate fi luată în calcul opinia parodontologului.
Ocluzie adâncă	Hawley + plan de mușcătură frontal	Retainer lingual fix 3-3	Menține purtarea nocturnă pe termen lung.
Ocluzie deschisă	Hawley (cu grilaj lingual dacă e cazul)	Retainer lingual fix sau Hawley	Monitorizarea obiceiurilor și a poziției limbii.
Ocluzie inversă posterioară (expansiune)	Hawley cu acoperire palatinală sau gutieră dură	După caz	Recidiva transversală apare precoce.
Corecția Clasei II	Hawley sau Essix; aparat funcțional nocturn dacă e cazul	Retainer lingual fix 3-3	Dacă există creștere, recidiva sagitală trebuie monitorizată.
Clasa III, creșterea continuă	Hawley sau Essix	Retainer lingual fix 3-3	Monitorizare lungă până la finalizarea creșterii; familia trebuie informată.
Caz cu extracții	Essix sau Hawley	Retainer lingual fix 3-3	Atenție la deschiderea spațiilor de extracție.
Adult cu pierdere de atașament parodontal	Retainer lingual fix lung	Retainer lingual fix lung	Monitorizare comună cu parodontologul; contenție pe termen nedeterminat.

Va purta pacientul regulat aparatul mobil? (vârstă, motivație, cooperare anterioară)

↓

Da → Aparat mobil în funcție de tipul problemei; la risc ridicat, completează cu retainer lingual fix.

Nu → În regiunile cu risc, retainerul lingual fix este obligatoriu; oferă aparatul mobil ca „asigurare suplimentară".

Despre durată

Nu există un singur răspuns corect pentru durata contenției. Abordarea actuală este să îi spui pacientului de la început: în orice situație în care stabilitatea este obiectivul, contenția este pe termen lung, de multe ori pe termen nedeterminat.

MODULUL 6

Protocol de Purtare și Calendar de Control

Atașează timpul de purtare și datele vizitelor de control la fișa pacientului.

Model de schemă de purtare (aparat mobil)

PERIOADĂ	PURTARE	CE VERIFICĂ MEDICUL
Prima perioadă după îndepărtare	Toată ziua, exceptând mesele și periajul (pe durata stabilită de medic).	Adaptarea, durerea, vorbirea, erupția.
Perioada de tranziție	Cu aprobarea medicului, noaptea + o parte din zi.	Deschiderea spațiilor, revenirea rotației.
Perioada pe termen lung	În fiecare noapte.	Uzura aparatului, senzația de tensiune.
Perioadă pe termen foarte lung	La decizia medicului, în timpul nopții sau în anumite nopți ale săptămânii.	Dacă apare senzația de „strângere”, crește frecvența.

Acest tabel este doar un cadru. Tu stabilești duratele în funcție de riscul cazului și le notezi în fișa pacientului.

Ordinea vizitei de control

1. **Anamneză** — Cât de des îl poartă? Strânge? A observat dezlipiri sau fracturi?
2. **Retainer lingual fix** — Verifică fiecare punct de compozit cu sonda; există spațiu între sârmă și compozit?
3. **Poziția dinților** — Rotație, spațiu, torque pe incisivi, nivelul caninilor. Compară cu fotografia sau modelul inițial.
4. **Aparat mobil** — Adaptare, fisuri, uzură, retenția croșetelor, igienă.
5. **Parodonțiu** — Tartru, sângerare, recesiune gingivală (în special la incisivii inferiori).
6. **Ocluzie** — Interferența aparatului sau a compozitului în timpul închiderii.
7. **Documentare** — Notează constatările și data următoarei vizite.

Calendar de control (de completat)

Data debarasării

Aparat maxilar

Aparat mandibular

Control 1

Control 2

Control 3

Control anual

Înlocuirea aparatului mobil

> **Eroare frecventă**
>
> Să lași pacientul să plece după debarasare cu mesajul „dacă ai probleme, revino”. Pacientul nu observă de cele mai multe ori recidiva; până când o observă, problema este deja avansată. Stabilește prima dată de control în ziua debarasării.

MODULUL 07

Gestionarea Fracturilor și Dezlipirilor

Fii clar cu privire la ce faci atunci când pacientul spune: „s-a dezlipit sârma".

Câte puncte s-au dezlipit și s-a deplasat dintele?

↓

Un punct, dintele este la locul lui → Curăță zona, asigură-te de poziția pasivă a sârmei și lipește din nou același punct.

Mai multe puncte sau dintele a migrat → Evaluează mai întâi dacă trebuie corectat dintele. Schimbă sârma; dacă este necesar, efectuează o corecție scurtă.

Același punct se dezlipește repetat?

↓

Da → Verifică contactul ocluzal, pasivitatea sârmei și izolarea. Adaptează din nou sârma sau confecționează una nouă.

Nu → Este suficientă recimentarea. Repetă pacientului avertismentele privind alimentele dure.

Înainte de a suna: regula pe care o dai pacientului

- Dacă s-a dezlipit sârma, cere o programare cât mai curând.
- Dacă ai un aparat mobil, poartă-l toată ziua până la vizită. Nu îndoi sârma singur; dacă te înțeapă, aplică ceară ortodontică.

SITUAȚIE	IMEDIAT	ULTERIOR
Sârma s-a rupt, capetele înțeapă	Finisează capetele sau îndepărtează fragmentul rupt	Sârmă nouă; între timp, aparat mobil
Sârma este intactă, dar dintele s-a deplasat	Consideră sârma activă, înlocuiește-o	Dacă este necesar, corecție scurtă și sârmă pasivă nouă
Aparatul mobil s-a rupt sau s-a pierdut	Amprentă/scanare nouă	Repararea aparatului existent sau gutieră temporară până la livrare

Eroare frecventă

Să recimentezi punctul dezlipit fără a corecta în prealabil dintele deplasat. Astfel, finalizezi recidiva. Verifică mai întâi poziția, apoi lipește.

MODULUL 08

Recidiva: Identificare și Intervenție

Depistează recidiva mică din timp, planifică din nou pe cea mare.

Semnele timpurii ale recidivei

Verifică la control

- [ ] Pacientul spune că aparatul mobil „strânge” sau nu se adaptează.
- [ ] Rotație ușoară sau deplasarea punctelor de contact la incisivi.
- [ ] Apariția spațiilor în zona extracțiilor sau a diastemei.
- [ ] Creșterea overjet-ului sau a overbite-ului.
- [ ] Modificare în linia mediană.
- [ ] În regiunea expandată, contactul posterior devine cuspid-cuspid.
- [ ] În cazul ocluziei deschise, pierderea contactului frontal.

GRADUL RECIDIVEI	EXEMPLU	ABORDARE
Ușoară	Rotație ușoară, spațiu mic; aparatul se adaptează greu.	Crește timpul de purtare. Control nou în scurt timp.
Medie	Aparatul nu se adaptează; deplasare marcată pe mai mulți dinți.	Documentație nouă, corecție limitată (tratament fix scurt sau serie de gutiere transparente) și contenție nouă.
Pronunțată	Relația ocluzală s-a modificat, overjet-ul/overbite-ul a revenit.	Rediagnosticare completă: de ce a revenit? Creștere, obicei vicios, limită osoasă?

Cauza recidivei a fost eliminată? (obiceiuri vicioase, creștere, stare parodontală)

↓

Da → Corecție + plan de contenție mai riguros.

Nu → Tratează mai întâi cauza. Corecția efectuată în timp ce cauza persistă va recidiva din nou.

Comunicarea cu pacientul

Explică recidiva fără a învinovăți: „Dinții au tendința de a se deplasa; de aceea folosim contenția. Acum există această modificare și iată cum o putem gestiona.” Oferă opțiunile și responsabilitatea purtării în scris.

Greșeală frecventă

Să consideri înghesuirile incisivilor inferiori la un pacient în creștere cu Clasa III drept „lipsă de cooperare”. Poate fi vorba de o creștere mandibulară tardivă. Reevaluează relația ocluzală și profilul.

MODULUL 9

Checklist pentru Aplicarea/Finalizarea Aparatului

În ziua debonding-ului, bifează această listă în prezența pacientului.

Înainte de debonding

- [ ] Obiectivele de finalizare verificate (ocluzie, paralelism radicular, torque, linie mediană).
- [ ] Obiceiurile vicioase și poziția limbii evaluate.
- [ ] Tipul și durata contenției explicate în prealabil pacientului și aprobate de acesta.
- [ ] Amprenta/scanarea finalizată, aparatul mobil este gata.
- [ ] Documentația finală realizată (foto, model/scanare, radiografie panoramică dacă este necesar).

Aplicarea retainerului lingual fix

- [ ] Sârma este pasivă: nu exercită presiune pe dinți, nu atinge gingia.
- [ ] Fiecare punct este complet acoperit de compozit, fără excese.
- [ ] Ața dentară trece prin zonele aproximale.
- [ ] În ocluzie, nici compozitul, nici sârma nu prezintă contacte.
- [ ] I-ai arătat pacientului tehnica de curățare cu superfloss.

Aplicarea aparatului mobil

- [ ] Aparatul se aplică fără forțare și are o retenție bună.
- [ ] Nu există margini tăioase, gingia și papilele nu sunt iritate.
- [ ] Pacientul a demonstrat inserția și îndepărtarea în fața oglinzii.
- [ ] Timpul de purtare a fost comunicat în scris.
- [ ] Ai explicat curățarea și utilizarea cutiei de depozitare.
- [ ] Ai înmânat fișa de informare a pacientului (Modulul 10).
- [ ] Ai stabilit data primei vizite de control.

MODULUL 10

Fișă de informare a pacientului (Text de înmânat)

Poți imprima această pagină pentru a o oferi pacientului tău.

Despre aparatul tău de contenție

Tratamentul tău s-a finalizat. Până când dinții se obișnuiesc cu noua lor poziție, aceștia au tendința de a reveni spre poziția inițială. Aparatul de contenție previne această mișcare. Contenția este parte din tratament, iar menținerea rezultatului depinde în mare măsură de tine.

Sârma fixă (în spatele dinților)

- Curăță zilnic zona de sub sârmă folosind superfloss.
- Nu mușca alimente dure (nuci, bomboane tari, gheață) cu dinții frontali.
- Dacă simți că sârma s-a dezlipit, s-a rupt sau te înțeapă, programează-te cât mai curând.
- Nu încerca să îndoi sau să tragi singur de sârmă.
- Vino la controale chiar dacă sârma pare în regulă.

Aparat mobil (gutieră)

- Poartă-l conform indicațiilor medicului tău.
- Scoate-l în timpul mesei și păstrează-l în cutia lui; nu îl înveli în șervețel.
- Curăță-l cu o periuță moale și apă rece/călduță. Apa fierbinte îl deformează.
- Dacă gutiera strânge, este semn că dinții se mișcă: poart-o mai regulat și anunță medicul.
- Dacă gutiera se rupe sau se pierde, solicită imediat o programare.

Calendarul tău de purtare

Aparat maxilar

Aparat mandibular

Timp de purtare (actual)

Data primei vizite de control

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examinarea clinică, decizia medicului și avizul specialistului.

Pasul următor

Contenția începe cu calitatea finalizării. Deschide acum **Modulul 08 · Finisare și Stabilitate** și, înainte de următorul pacient programat pentru debonding, parcurge verificările de finalizare. Apoi continuă cu **Atlas de Tuburi Ortodontice** (Ghidul 3 / 5).